



Dossier Médical

DAVIS BIZZY

Identité : Davis Bizzy

Date de naissance : 20 Juillet 2003

Téléphone : 555-4092

**ADMISSION: 31 JAN 2026 À 13:33****MOTIF DE CONSULTATION**

BPB Membre inférieur

TRAITEMENT

(Reprise du dossier, suppression de l'ancien, date inconnue) Motif d'admission Le patient a été admis aux urgences suite à une plaie par arme à feu au membre inférieur gauche. Le projectile était non traversant, logé superficiellement dans les tissus mous et déjà partiellement en train de ressortir lors de l'admission. Bilan médical Les examens cliniques et d'imagerie n'ont révélé : Aucune fracture osseuse Aucune atteinte vasculaire ou nerveuse Aucun dégât musculaire majeur L'état général du patient était stable. Une intervention chirurgicale mineure a été réalisée sous anesthésie locale afin de : Extraire le projectile Nettoyer et désinfecter la plaie Effectuer une suture simple L'intervention s'est parfaitement déroulée, sans complication.

ADMISSION: 3 FEB 2026 À 23:40**MOTIF DE CONSULTATION**

Addictologie

DIAGNOSTIC

Addiction héroïne de suite une pique sauvage

TRAITEMENT

Cure donné doit repassé dans 2j





ADMISSION: 1 MAR 2026 À 02:26

MOTIF DE CONSULTATION

Admission suite à une explosion dans une station-service, avec brûlures localisées au niveau cervical. (Elias Varn)

DIAGNOSTIC

Brûlure thermique du 3^e degré localisée autour du cou. Aggravation des lésions cutanées liée à la présence d'une chaîne en or, ayant concentré la chaleur et accentué la brûlure par conduction thermique. Zone nécrosée correspondant à la forme du collier. Atteinte cutanée profonde mais zone relativement restreinte. Absence de détresse respiratoire ou de brûlure des voies aériennes identifiée.

TRAITEMENT

Retrait de la chaîne en or après débridement des tissus nécrosés autour du bijou. Nettoyage approfondi de la zone brûlée. Désinfection locale selon protocole grands brûlés. Hydratation cutanée adaptée. Mise en place d'un bandage spécialisé pour brûlure profonde. Antalgie prescrite. Antibioprophylaxie selon évaluation clinique. SUIVI Retour sous 24 heures pour changement de pansement et réévaluation de la zone brûlée. Surveillance des signes infectieux (rougeur étendue, écoulement, fièvre). Évaluation ultérieure de la nécessité d'une greffe cutanée selon évolution.





ADMISSION: 2 MAR 2026 À 02:40

MOTIF DE CONSULTATION

bpb

DIAGNOSTIC

balle traversante tibia gauche

TRAITEMENT

M – Mécanisme de blessure Blessure par arme à feu. Balle traversante au niveau du tibia gauche. I – Injuries (Blessures constatées) Plaie d'entrée et de sortie au tibia gauche Atteinte des tissus mous Pas de signe immédiat de fracture ouverte Saignement contrôlé Sensibilité conservée distalement S – Signes vitaux / État du patient Patient conscient et coopérant Douleur modérée à sévère avant prise en charge Hémodynamiquement stable Pas de perte de connaissance T – Traitement effectué Anesthésie locale Nettoyage et irrigation de la plaie Pansement compressif Immobilisation du membre inférieur gauche Surveillance de la douleur et du saignement

